

■ PROTOCOLO CLÍNICO

CUIDADOS PALIATIVOS

UTI · Enfermaria · Medicina Interna

Limitação Terapêutica · Performance Status · Controle de Sintomas Abordagem Familiar · Enxugamento de Prescrição

Dr. Aldenir Rocha | CRM-CE 16587 | RQE Clínica Médica 11846
Hospital Regional Norte · Santa Casa de Misericórdia de Sobral · CE
Atualizado: Abril / 2026

1 · CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA CUIDADOS PALIATIVOS

Pergunta-gatilho (Surprise Question): "Você se surpreenderia se este paciente falecesse nos próximos 12 meses?"
Se NÃO → acionar avaliação paliativa.

DOMÍNIO	INDICADORES CLÍNICOS
Oncológico	Doença metastática sem opção curativa; ECOG ≥ 3 ; perda ponderal $> 10\%$ em 3 meses
Insuf. Cardíaca	NYHA IV refratária; BNP elevado; múltiplas internações; FEVE $< 25\%$
DPOC / Resp.	VEF1 $< 30\%$; dependência de O2 domiciliar; hipercapnia crônica; disfagia
Renal	TFG < 15 mL/min; diálise recusada; uremia sintomática refratária
Hepático	Child-Pugh C; MELD > 20 ; sangramento varicoso recorrente; EH recorrente
Neurológico	AVC extenso com Glasgow ≤ 8 sem melhora; demência avançada; ELA ALSFRS < 18
Geriatrico/Frágil	Clinical Frailty Scale ≥ 7 ; polifarmácia > 10 fármacos; quedas recorrentes
Politrauma/Séptico	SOFA > 11 sem resposta; MOF; família solicitante de conforto

■ A elegibilidade é CLÍNICA e PROCESSUAL — não depende apenas de diagnóstico. Envolve prognóstico, funcionalidade, valores e preferências do paciente.

2 · ESCALAS DE PERFORMANCE STATUS

2.1 ECOG Performance Status (Eastern Cooperative Oncology Group)

ECOG	DESCRIÇÃO	INTERPRETAÇÃO PALIATIVA
0	Assintomático; atividade normal	Cuidados paliativos precoces (apoio)
1	Sintomático; ativ. leve restrita	Discussão de metas; DNR precoce
2	Sintomático; $\leq 50\%$ do dia acamado	Introdução formal de paliativos
3	Limitado; $> 50\%$ do dia acamado	Prioridade ao conforto; LTM indicada
4	Acamado; totalmente dependente	Cuidados exclusivos de conforto

2.2 Karnofsky Performance Scale (KPS)

KPS %	DESCRIÇÃO	SOBREVIDA ESTIMADA
100–80	Ativo; capaz de trabalhar; poucos sintomas	> 6 meses (variável)
70–60	Cuida de si; não trabalha; $> 50\%$ ambulante	3–6 meses
50–40	Necessita assistência frequente; $> 50\%$ acamado	1–3 meses
30–20	Muito debilitado; suporte médico intensivo	Semanas
< 20	Moribundo; processo ativo de morte	Dias a horas

2.3 Palliative Performance Scale (PPS)

PPS %	DEAMBULAÇÃO	ATIVIDADE	AUTOCUIDADO	INGESTÃO	CONSCIÊNCIA
100	Total	Normal	Total	Normal	Clara
80	Total	Normal c/ esforço	Total	Normal/reduz.	Clara
60	Reduzida	Limitada	Ocasional ajuda	Normal/reduz.	Clara/confusão
40	Acamado	Mínima	Máxima ajuda	Normal/reduz.	Clara/sonolência

20	Acamado	Nenhuma	Cuidado total	Mínima (goles)	Sonolência/coma
10	Acamado	Nenhuma	Cuidado total	Boca úmida	Sonolência/coma

2.4 Clinical Frailty Scale (CFS) — Rockwood

CFS	CATEGORIA	DESCRIÇÃO
1	Muito ativo	Exercício regular intenso; em forma
2	Bem	Sem doença ativa; exercício ocasional
3	Bem c/ comorbidade	Sintomas controlados; inativo
4	Vulnerável	Cansaço; atividade reduzida
5	Levemente frágil	Lentidão; necessita apoio em AIVD
6	Moderadamente frágil	Necessita ajuda em ABVD e AIVD
7	Severamente frágil	Totalmente dependente; mas estável
8	Muito severamente frágil	Dependente; terminalidade próxima
9	Doença terminal	Expectativa de vida < 6 meses

■ $CFS \geq 7 + ECOG \geq 3 + PPS \leq 40\% \rightarrow$ fortemente indicativo de cuidados exclusivos de conforto / LTM IV

3 · GRAUS DE LIMITAÇÃO TERAPÊUTICA (LTM)

A LTM deve ser registrada em prontuário com **data, hora, nome e CRM** do médico responsável, justificativa clínica e prognóstica, e sempre que possível com anuência do paciente / família.

NÍVEL	DENOMINAÇÃO	O QUE SE LIMITA	O QUE SE MANTÉM
LTM I	Não-RCP (DNR/DNI)	Manobras de RCP; desfibrilação; intubação orotraqueal	Todos demais tratamentos: UTI, vasopressores, antibióticos
LTM II	Não-escalada terapêutica	Novos procedimentos invasivos; novos vasopressores; novas diálises	Tratamentos em uso, conforto, sedação, suporte de UTI, enfermagem
LTM III	Retirada de suporte (WLS)	Ventilação mecânica; diálise; vasopressores em uso	Analgesia; sedação; higiene; cuidados de conforto
LTM IV	Cuidados exclusivos de conforto	Qualquer medida que não vise o conforto imediato	Analgesia; sedação; higiene; companhia; espiritualidade

■ **ATENÇÃO LEGAL: A LTM não é eutanásia. É respaldada pelo CFM (Res. 1.805/2006 e 2.232/2019), pelo Código de Ética Médica (Art. 41) e pela Resolução CFM 2.156/2016 (UTI). O médico que recusa LTM indicada pode responder eticamente por obstinação terapêutica.**

3.1 Critérios para indicação de cada nível

LTM I (DNR/DNI)	ECOG ≥ 3 OU CFS ≥ 7 OU doença terminal com baixa chance de reversão da parada
LTM II	SOFA > 11 sem melhora em 72h; falência de ≥ 3 órgãos; doença de base irreversível avançada
LTM III (WLS)	Ventilação > 21 dias sem desmame; MOF irreversível; solicitação do paciente (DAV)
LTM IV	PPS ≤ 20%; agonia ativa; família/paciente optam por conforto exclusivo

4 · ABORDAGEM DA FAMÍLIA E DO PACIENTE

4.1 Conferência Familiar — Protocolo SPIKES

ETAPA	SIGLA	AÇÃO PRÁTICA
Setting up	S	Reunião privada; todos os familiares-chave; sentar; desligar celular; sem pressa
Perception	P	Perguntar o que a família já sabe: "O que os médicos já explicaram sobre a situação?"
Invitation	I	Verificar quanto querem saber: "Você quer que eu explique tudo em detalhes?"
Knowledge	K	Dar informação em linguagem clara; frases curtas; evitar jargões; pausar
Emotions	E	Reconhecer emoções; tolerar silêncio; não apressar; validar o sofrimento
Strategy	S	Apresentar plano de cuidados; discutir LTM; dar esperança realista (conforto, dignidade)

4.2 Frases-modelo para comunicação de más notícias

SITUAÇÃO	FRASE VALIDADA
Abertura empática	"Sei que tem sido um momento muito difícil para todos vocês."
Comunicar prognóstico ruim	"Infelizmente, a doença avançou muito e não temos como reverter-la."
Propor LTM	"Ao invés de fazer procedimentos que causariam mais sofrimento, queremos focar no conforto."
Responder "Fez tudo?"	"Sim, fizemos tudo o que a medicina pode oferecer para tratar a doença. Agora vamos cuidar da pessoa."
Sinalização de morte iminente	"Nas próximas horas/dias, o corpo está se desligando. É importante estarem perto dele."
Encerrar conferência	"Estarei disponível para qualquer dúvida. Não vão enfrentar isso sozinhos."

4.3 Checklist da Conferência Familiar

- Ambiente privado e confortável garantido
- Todos familiares-chave presentes (ou ligação por vídeo)
- Paciente incluído se tiver capacidade decisória
- Equipe multiprofissional convidada (enfermagem, psicologia, serviço social)
- Percepção da família avaliada antes de informar
- LTM apresentada como proposta, não imposição
- Perguntas respondidas; tempo para choro e silêncio
- Plano de cuidados registrado em prontuário após reunião
- Próxima reunião agendada (ou critérios para nova convocação definidos)
- Informações sobre suporte espiritual/capelanía oferecidas

5 · PROTOCOLO DE CONTROLE DE SINTOMAS

■ Doses abaixo são para adultos com função renal/hepática adequada. Ajustar em idosos, renais crônicos e caquéticos. Preferir via SC ou SL quando VO não for possível.

5.1 DOR

INTENSIDADE	FÁRMACO	DOSE	VIA	INTERVALO	OBSERVAÇÃO
Leve (EVA 1–3)	Paracetamol	500–1000 mg	VO/EV	6/6h	Máx 4g/dia; hepatotóxico
Leve (EVA 1–3)	Dipirona	500–1000 mg	VO/EV/SC	6/6h	Segura em paliativo
Moderada (EVA 4–6)	Tramadol	50–100 mg	VO/EV/SC	6/6h	Máx 400 mg/dia; serotoninérgico
Moderada (EVA 4–6)	Codeína	30–60 mg	VO	4/4–6/6h	Associar laxante desde o início
Intensa (EVA 7–10)	Morfina	5–10 mg	VO	4/4h	Titular; dose resgate = 1/6 da dose diária
Intensa (EVA 7–10)	Morfina	2–5 mg	EV/SC	4/4h ou SOS	Bomba SC contínua: 10–30 mg/24h
Intensa refratária	Metadona	5–10 mg	VO/SC	8/8–12/12h	QTc; interações; especialista
Dor neuropática	Amitriptilina	10–25 mg	VO	Noite	Adjuvante analgésico
Dor neuropática	Gabapentina	300 mg	VO	8/8h (titular)	Sedação; ajustar em renal
Dor neuropática	Dexametasona	4–8 mg	EV/VO	12/12h	Compressão medular/óssea

5.2 DISPNEIA

FÁRMACO	DOSE	VIA	INTERVALO	OBSERVAÇÃO
Morfina	2–5 mg	SC/EV	SOS ou 4/4h	1ª linha; reduz sensação de falta de ar
Morfina (bomba)	10–20 mg/24h	SC contínua	Contínua	Titular conforme resposta
Midazolam	2,5–5 mg	SC/EV	SOS	Se ansiedade associada; também sedação paliativa
Lorazepam SL	0,5–1 mg	SL	SOS	Útil no domicílio; rápido início
O2 nasal	2–4 L/min	Inalatória	Contínuo	Apenas se SpO2 < 90% ou conforto demonstrado
Dexametasona	4–8 mg	EV/SC	12/12h	Linfangite carcinomatosa; obstrução das vias aéreas

5.3 NÁUSEAS E VÔMITOS

FÁRMACO	DOSE	VIA	INTERVALO	INDICAÇÃO PREFERENCIAL
Ondansetrona	4–8 mg	VO/EV/SC	8/8h	Quimioterapia; pós-operatório
Metoclopramida	10 mg	VO/EV/SC	8/8h	Estase gástrica; gastroparesia
Haloperidol	0,5–2 mg	SC/EV/VO	12/12h	Náusea por opioides; distúrbio metabólico
Dexametasona	4–8 mg	EV/SC	12/12h	HIC; compressão intestinal; quimio
Escopolamina	0,5 mg	SC/EV	6/6h	Cólica; náusea + sialorreia excessiva
Domperidona	10 mg	VO	8/8h	Gastroparesia; 1ª linha em estase (VO disponível)

5.4 AGITAÇÃO / DELIRIUM / SEDAÇÃO PALIATIVA

FÁRMACO	DOSE	VIA	INTERVALO	OBSERVAÇÃO
Haloperidol	0,5–2 mg	SC/EV/VO	6/6–12/12h	1ª linha delirium; evitar em Parkinson
Clorpromazina	12,5–50 mg	VO/EV	6/6–8/8h	Alternativa ao haloperidol; mais sedante

Midazolam	2,5–5 mg	SC/EV	SOS ou contínuo	Sedação paliativa; titular
Midazolam (bomba)	10–60 mg/24h	SC contínua	Contínua	Ajuste a cada 4h até conforto
Fenobarbital	50–100 mg	SC/EV	8/8–12/12h	Delirium refratário; convulsões
Levomepromazina	6,25–25 mg	SC/EV	6/6–12/12h	Sedação + analgesia + antiemético
Lorazepam	0,5–2 mg	EV/SL	SOS	Ansiedade; delirium hiperativo

5.5 OUTROS SINTOMAS FREQUENTES

SINTOMA	FÁRMACO	DOSE	VIA	OBSERVAÇÃO
Constipação	Lactulose	15–30 mL	VO	Todo paciente em opioide deve receber laxante
Constipação	Bisacodil	5–10 mg	VO/Ret	Se sem resposta a lactulose
Sialorreia/Estertores	Escopolamina	0,5 mg	SC	Secar secreções; "rale da morte"
Sialorreia/Estertores	Atropina 1%	2 gts SL	SL	Alternativa ao fim da vida
Prurido (opioides)	Ondansetrona	4 mg	EV	Ou trocar opioide
Prurido (icterícia)	Colestiramina	4 g	VO	8/8h às refeições
Mioclonias/opioides	Clonazepam	0,5–1 mg	VO/SL	Ou trocar morfina por metadona
Insônia/Ansiedade	Clonazepam	0,5–2 mg	VO	À noite; cuidado idoso
Febre paliativa	Dipirona	500–1000 mg	VO/EV	Evitar AINE em renais/hepatopatas
Sangramento/Hemorragia	Etamsilato	250–500 mg	EV	Compressas escuras + midazolam SOS
Úlcera péptica/dispepsia	Omeprazol	20 mg	VO	Revisar se ainda necessário

6 · PLANO DE ENXUGAMENTO DE PRESCRIÇÃO

Princípio: Em paliativo, cada medicamento deve ter um propósito orientado para **conforto ou qualidade de vida imediata**. Descontinuar o que trata doença de base, previne eventos futuros ou gera ônus sem benefício.

6.1 Framework STOPP/STARTpalliative — Classificação de fármacos

CATEGORIA	EXEMPLOS	CONDUTA
■ SUSPENDER imediatamente	Estatinas, antiplaquetários, anticoagulantes (sem indicação	Não controlar sintomas, hipoglicemia (glicemia
■ SUSPENDER após discussão	Anti-hipertensivos (PA-alvo liberal $\geq 150/90$), hormônio tireoide	Manter, iniciar dose de substituição (disórtica terminal), IS
■ MANTER / INICIAR se necessário	Opioides, laxantes, antieméticos, corticoides, benzodiazepí	Tratar sintomas (se sintomas de infecção), antifúngicos
■ REVISAR periodicamente	Omeprazol (se não houver dispepsia), diuréticos (edema assintomático)	Substituir antidepressivos (se não há revisão)

6.2 Protocolo passo a passo — Revisão da Prescrição

- PASSO 1:** Listar TODOS os fármacos com indicação original
- PASSO 2:** Para cada fármaco perguntar: "Este fármaco melhora sintomas ou qualidade de vida AGORA?"
- PASSO 3:** Classificar em: Suspende | Manter | Reduzir dose | Trocar via
- PASSO 4:** Simplificar horários: 2x/dia sempre que possível → reduz falhas e sofrimento
- PASSO 5:** Priorizar via oral → SC → EV (menos invasivo)
- PASSO 6:** Rever monitorização: suspender dosagens desnecessárias (HbA1c, TSH, INR sem anticoag ativo)
- PASSO 7:** Documentar no prontuário com justificativa de cada suspensão
- PASSO 8:** Comunicar mudanças à família e equipe de enfermagem

6.3 Fármacos frequentemente desnecessários em paliativo (lista rápida)

SUSPENDER	MANTER / INICIAR
Estatinas / fibratos	Morfina (dor, dispneia)
Antiplaquetários (AAS, clopidogrel)	Dipirona / Paracetamol
Anticoagulantes (sem EP/TVP sintomática)	Metoclopramida / Ondansetrona
Metformina / sulfonilureias	Haloperidol (delirium)
Bifosfonatos / denosumabe	Midazolam (ansiedade, sedação)
Suplementos vitamínicos / minerais	Dexametasona (edema, dor óssea)
IECAs / BRAs (se PA-alvo liberal)	Laxante (todo opioide)
Betabloqueador (se bradicárdico)	Escopolamina (estertores)
Diuréticos (edema assintomático)	Clonazepam (insônia, ansiedade)
Hipnóticos crônicos (se sedação adequada)	Antibiótico (se infecção sintomática)

7 · SELETIVIDADE DE EXAMES EM PALIATIVO

Regra geral: Solicitar exame apenas se o resultado mudará a conduta de conforto. "Exame que não muda conduta não deve ser solicitado."

EXAME	SOLICITAR?	JUSTIFICATIVA
Hemograma	Raramente	Só se suspeita de sangramento ativo ou neutropenia febril sintomática
Glicemia capilar	Sim (reduzida)	Meta liberal: 150–250 mg/dL; suspender se desconfortável
Eletrólitos (Na, K)	Raramente	Apenas se hiponatremia sintomática ou hipercalemia grave
Função renal (Cr, Ur)	Raramente	Ajuste de dose de opioides; se delirium inexplicado
Função hepática	Não	Não muda conduta em paliativo exclusivo
HbA1c	Não	Sem indicação em paliativo; controle glicêmico não é objetivo
TSH / T4	Não	Sem indicação em paliativo exclusivo
INR / coagulograma	Raramente	Se anticoagulação para conforto (ex: EP sintomática)
PCR / culturas	Só se mudar conduta	Antibiótico para conforto → cultura pode ajudar a escolha
Radiografia tórax	Raramente	Se dispneia refratária e resultado pode mudar abordagem
TC / RNM	Não	Sem indicação em paliativo exclusivo; avaliar caso a caso
ECG	Raramente	Se QTc relevante (haloperidol/metadona em doses altas)
Ecocardiograma	Não	Não muda conduta em paliativo
GASOMETRIA	Não	Exceto se mudaria decisão de ventilar (raro em LTM III/IV)
Saturimetria (SpO2)	Sim	Útil para conforto; suspender monitorização contínua em LTM IV
Peso diário	Sim	Monitorar retenção se desconfortável; suspender se agônico

8 · PRESCRIÇÃO-MODELO — PALIATIVO EXCLUSIVO (LTM IV)

■ Modelo orientativo. Individualizar doses conforme peso, função renal, tolerância prévia a opioides e intensidade dos sintomas.

#	FÁRMACO	DOSE	VIA	FREQ.	INDICAÇÃO
1	Dipirona sódica	500 mg	SC/EV	6/6h	Analgesia / antipirético
2	Morfina (ampola 10 mg/mL)	5 mg	SC	4/4h	Dor / dispneia; titular
3	Morfina RESGATE	2,5 mg	SC	SOS 1/1h	Se EVA > 4 / dispneia aguda
4	Midazolam	5 mg	SC	SOS	Agitação / ansiedade aguda
5	Haloperidol	1 mg	SC	12/12h	Delirium / náusea por opioide
6	Metoclopramida	10 mg	SC	8/8h	Náuseas
7	Escopolamina	0,5 mg	SC	6/6h	Estertores / hipersecreção
8	Lactulose	15 mL	VO/SNG	12/12h	Constipação (todo opioide)
9	Dexametasona	4 mg	SC/EV	12/12h	Dor óssea/neuropática; anorexia
10	Clonazepam 2 mg	0,5 mg	VO/SL	Noite	Insônia / ansiedade
■■	■■■■ SUSPENDER ■■■■	■■	■■	■■	Estatina · AAS · IECA · Metformina · Omeprazol (se s/ dispepsia)
■■	MONITORIZAÇÃO	■■	■■	■■	EVA 4/4h · sedação · FR · SpO2 (se confortável) · diurese

8.1 Bomba de infusão SC contínua — Fórmula-padrão (syringe driver 24h)

FÁRMACO	DOSE 24H	DILUENTE	OBSERVAÇÃO
Morfina	20–60 mg/24h (titular)	SF 0,9%	Iniciar com dose oral × 1/3
Midazolam	10–30 mg/24h (titular)	SF 0,9%	Compatível com morfina na mesma seringa
Haloperidol	3–5 mg/24h	SF 0,9%	Compatível com morfina + midazolam
Metoclopramida	30 mg/24h	SF 0,9%	Compatível na mesma seringa
Escopolamina	1,5–2,4 mg/24h	SF 0,9%	Compatível com morfina
Dexametasona	Separado	SF 0,9%	Não misturar com outros na mesma seringa

9 · SEDAÇÃO PALIATIVA — PROTOCOLO

Definição: Redução intencional da consciência para alívio de sofrimento refratário em paciente em fase terminal. **NÃO é eutanásia.** Respalhada pelo CFM Res. 1.805/2006.

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
Indicação	Sofrimento físico ou psíquico refratário (dor, dispneia, delirium, angústia existencial)
Refratariedade	Sintoma não controlado após 48–72h de manejo otimizado com especialista
Prognóstico	Expectativa de vida de horas a dias (fase agônica)
Consentimento	Documentar em prontuário; obter anuência familiar (ou DAV do paciente)
Proporcionalidade	Dose mínima para controle do sintoma; não antecipar morte
Documentação	Indicação, fármaco, dose, horário, nome/CRM e assinatura do médico

9.1 Protocolo de sedação paliativa

FÁRMACO	DOSE INICIAL	TITULAÇÃO	MANUTENÇÃO 24H
Midazolam	2,5–5 mg SC/EV em bolus	Repetir SOS a cada 15–30 min	10–60 mg/24h SC contínua
Levomepromazina	6,25–12,5 mg SC	A cada 2h se necessário	25–150 mg/24h SC contínua
Fenobarbital	50–100 mg SC/EV	Repetir a cada 30 min (máx 3×)	200–800 mg/24h SC contínua
Propofol (UTI)	0,5–1 mg/kg/h EV	Titular a cada 30 min	1–4 mg/kg/h (titular)
Cetamina (adjuvante)	0,5–1 mg/kg/h EV	—	Com midazolam; dor neuropática refrat.

9.2 Monitorização durante sedação paliativa

- Escala de Ramsay a cada 2h (objetivo: Ramsay 4–5)
- Frequência respiratória (não manter < 6 irpm)
- Ausência de caretas, gemidos, sinais de desconforto
- Suspender monitorização invasiva (PA, SpO2) após Ramsay 5
- Manter higiene oral, olhos úmidos, decúbito preferencial
- Manter companhia familiar; oferecer suporte espiritual

10 · RECONHECIMENTO DA FASE AGÔNICA E MORTE IMINENTE

SINAL	DESCRIÇÃO	CONDUTA
Respiração de Cheyne-Stokes	Alternância apneia/hiperpneia	Morfina SC; explicar à família
Estertores ("rale")	Ruído por secreção em vias aéreas	Escopolamina SC; decúbito lateral
Livedo / cianose distal	Moteamento em extremidades	Normais na agonia; informar família
Extremidades frias	Periférica → central	Normal; manter aquecimento leve
Inconsciência	Sem resposta a estímulos verbais	Manter analgesia; sedação se agitação
Olhos entreabertos	Relaxamento palpebral	Lubrificar olhos; compressas úmidas
Abolição reflexo deglutição	Disfagia total	Via SC; suspender VO; higiene oral
Oligúria < 100 mL/24h	Falência renal funcional	Suspender diuréticos; hidratação mínima
Tempo estimado	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	Horas a dias após presença de ≥ 3 sinais acima

■ **Comunicar proativamente à família: "Seu familiar está na fase final. O mais importante agora é que ele não sofra e que esteja cercado de quem ama."**

11 · DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE (DAV)

Resolução CFM 1.995/2012 — O médico deve registrar em prontuário e respeitar as DAV do paciente capaz, inclusive quando conflitar com o desejo familiar.

- Perguntar em consulta ou 1ª avaliação: "Já pensou em deixar registrado o que deseja caso fique gravemente doente?"
- Oferecer formulário de DAV e documentar no prontuário
- Revisar periodicamente: quadro clínico pode mudar valores e preferências
- Em ausência de DAV: decisão compartilhada com família + equipe, priorizando o melhor interesse do paciente
- Em conflito família x equipe: acionar Comitê de Bioética Hospitalar

12 · INDICADORES DE QUALIDADE EM CUIDADOS PALIATIVOS

INDICADOR	META
Conferência familiar documentada em até 48h da admissão de paliativo	> 90%
LTM registrada em prontuário com justificativa	100%
Avaliação de dor com escala validada (EVA/ESAS) em 4/4h	> 95%
Prescrição de laxante em todo paciente usando opioide	100%
Número de fármacos na prescrição de paliativo exclusivo	< 8 fármacos
Exames laboratoriais por internação em paliativo exclusivo	< 3 solicitações/semana
Paciente falece sem dor ou com dor controlada (EVA < 4)	> 85%
Família recebe suporte de luto após óbito	> 80%

REFERÊNCIAS E BASES CIENTÍFICAS

- [1] WHO. Palliative Care. Key Facts. 2020.
- [2] CFM. Resolução 1.805/2006 — Terminalidade de vida.
- [3] CFM. Resolução 2.232/2019 — Obstinação terapêutica.
- [4] CFM. Resolução 1.995/2012 — Diretivas Antecipadas de Vontade.
- [5] CFM. Resolução 2.156/2016 — Classificação e critérios de internação em UTI.
- [6] ANCP. Manual de Cuidados Paliativos. 3ª ed. 2021.
- [7] Hui D, Bruera E. The Edmonton Symptom Assessment System 25 Years Later. J Pain Symptom Manage. 2017.
- [8] Twycross R. Palliative Care Formulary. 7th ed. Radcliffe Medical Press. 2022.
- [9] Cherny NI. ESMO Clinical Practice Guidelines for palliative sedation. Ann Oncol. 2020.
- [10] Lim RBL. End-of-life care in patients with advanced lung cancer. Ther Adv Respir Dis. 2016.
- [11] Stiell IG et al. CPR in terminally ill patients. NEJM. 2014.
- [12] Moss AH et al. Prognostic tool for dialysis discontinuation. CJASN. 2010.
- [13] Rockwood K. A global clinical measure of fitness — CFS. CMAJ. 2005.
- [14] Anderson F et al. Palliative Performance Scale (PPS). J Palliat Care. 1996.
- [15] Stiel S et al. Validation of MIDOS scale in palliative care. J Pain Symptom Manage. 2010.
- [16] IAHP. List of Essential Medicines for Palliative Care. 2021.

Protocolo elaborado por Dr. Aldenir Rocha · CRM-CE 16587 · RQE Clínica Médica 11846 · Hospital Regional Norte · Santa Casa de Misericórdia de Sobral · CE · Abril/2026 · Este documento é de uso clínico auxiliar; não substitui julgamento clínico individualizado.